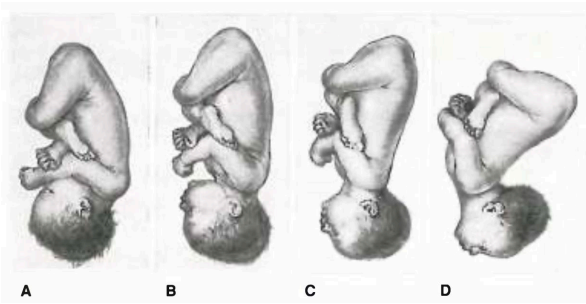
KULIAH OBSTETRI & GINEKOLOGI

Malpresentasi

Anandha Mardhia Prefitri

Departeman Obstetri dan Ginekologi
Universitas Hasanuddin



01

Konsep Dasar Presentasi Janin

Letak, presentasi, posisi · Definisi · Spektrum fleksi–ekstensi · Presentasi bokong · Insidensi

Fetal Lie, Presentation, and Position

Tiga parameter untuk mendeskripsikan janin terhadap ibu dan panggul

1 FETAL LIE

Hubungan antara sumbu panjang janin dengan sumbu panjang ibu/uterus.

Bagaimana letak janin?

Ada 3 :

Longitudinal • Transverse • Oblique

2 FETAL PRESENTATION

Bagian terendah janin yang paling dekat dengan pelvic inlet dan memasuki jalan lahir terlebih dahulu.

Bagian terbawah janin?

Cephalic • Breech • Shoulder

3 FETAL POSITION

Hubungan denominator pada presenting part terhadap sisi dan bagian pelvis ibu.

Menghadap ke mana?

LOA • ROA • LOP • ROP

Denominator: titik penunjuk atau landasan tulang anatomis (bony landmark) pada bagian presentasi janin yang digunakan sebagai titik acuan untuk menentukan posisi janin relatif terhadap panggul ibu.

Definisi Malpresentasi

DEFINISI

Malpresentasi adalah semua presentasi janin selain presentasi belakang kepala.

NORMAL

Belakang kepala (vertex / oksiput)

karena kher fleksi

MALPRESENTASI

Puncak kepala

klo tdk fleksi

Dahi

klo ekstensi

Muka

Bokong

Bahu / lintang

Presentasi Kepala: Spektrum Fleksi–Ekstensi

Presenting part ditentukan oleh derajat fleksi atau ekstensi kepala janin

FLEKSI → **EKSTENSI**

Belakang Kepala
VERTEX / OCCIPUT

Fleksi maksimal

Dagu mendekati toraks. Fontanel posterior/oksiput menjadi presenting part.

Puncak Kepala
SINCIPUT

Fleksi parsial

Kepala hanya sebagian fleksi. Fontanel anterior (besar) menjadi presenting part.

Dahi
BROW

Ekstensi parsial

Leher hanya sebagian ekstensi. Dahi (brow) menjadi presenting part.

Muka
FACE

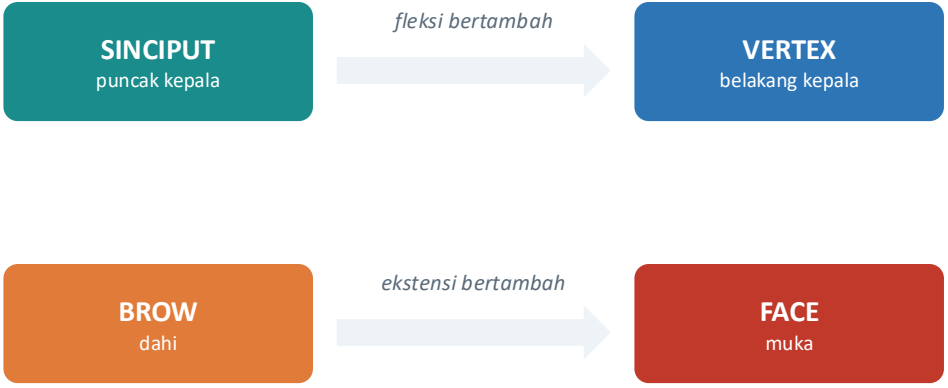
Ekstensi maksimal

Leher sangat ekstensi. Wajah menjadi bagian terdepan di jalan lahir.

Vertex adalah presentasi kepala yang paling lazim; sinciput dan brow umumnya merupakan presentasi transien.

Perubahan Presentasi Selama Persalinan

Sinciput dan brow biasanya berubah seiring bertambahnya fleksi atau ekstensi leher

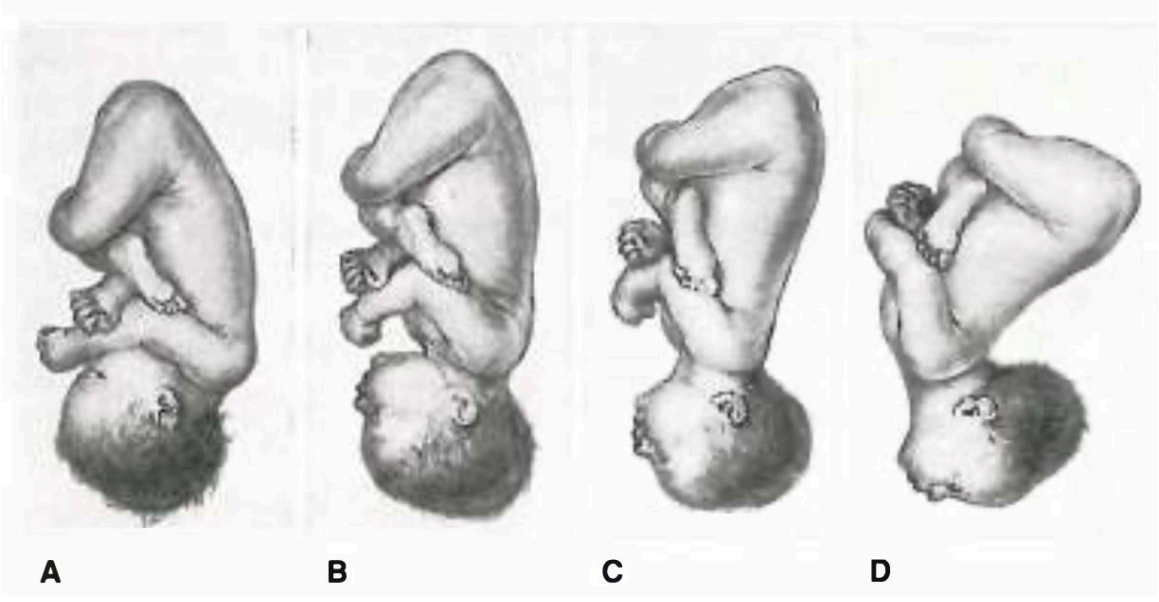


IMPLIKASI KLINIS

- Sinciput dan brow biasanya bersifat sementara.
- Jika tidak terjadi konversi menjadi vertex atau face, kemajuan persalinan dapat terganggu.
- Persistensi presentasi abnormal dapat menyebabkan distosia.

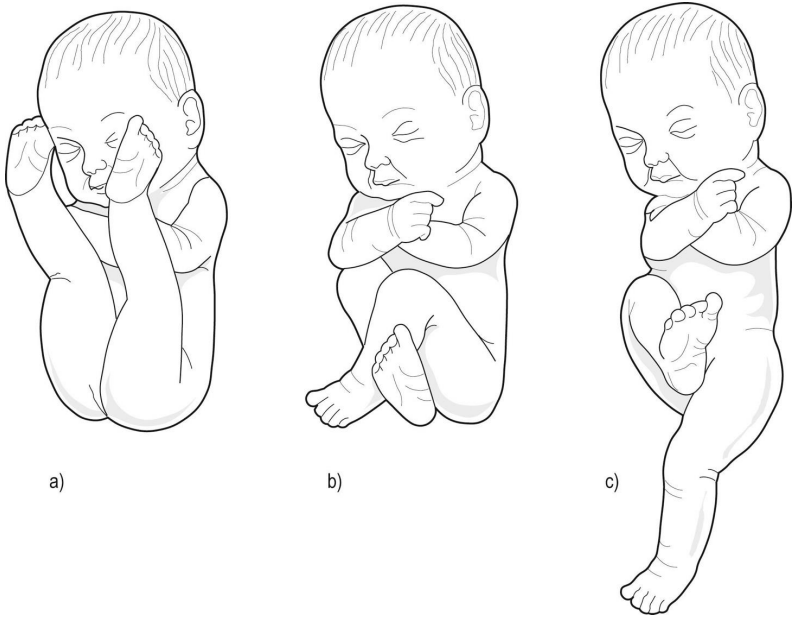
Sikap Kepala Janin: dari Vertex hingga Muka

A · Belakang kepala B · Puncak kepala C · Dahi D · Muka



Presentasi Bokong

Breech presentation — dibedakan menurut sikap panggul dan lutut janin



a **Bokong murni** *Frank breech*

Panggul fleksi, lutut ekstensi; bagian terendah: bokong.

b **Bokong sempurna** *Complete breech*

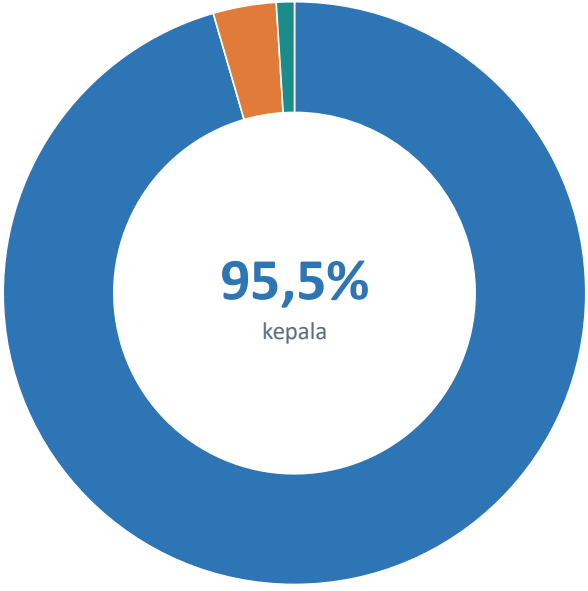
Panggul dan lutut fleksi; bagian terendah: bokong.

c **Presentasi kaki** *Footling breech*

Panggul dan lutut ekstensi; bagian terendah: kaki.

Insidensi Presentasi Janin

Fetal presentation at pelvic entry



95,5% Presentasi kepala (cephalic)

3,5% Presentasi bokong (breech)

1% Letak lintang/oblik atau presentasi muka/dahi

02

Faktor Predisposisi & Diagnosis

Faktor maternal dan uterus · Faktor janin, plasenta, selaput ketuban · Diagnosis · Denominator · Hubungan fetopelvik

Faktor Maternal dan Uterus

Faktor predisposisi malpresentasi dan malposisi janin

1

Panggul sempit

Menghambat engagement bagian terendah janin.

2

Anomali uterus

Pada uterus bikornu, tanduk yang tidak hamil dapat menghambat persalinan.

3

Abdomen pendulans

Uterus dan janin jatuh ke depan, sehingga engagement sulit.

4

Kelainan ukuran / lokasi plasenta

Berkaitan dengan posisi janin yang kurang menguntungkan.

5

Massa pelvis

Mioma uteri atau kista ovarium menghalangi pintu masuk panggul.

6

Paritas tinggi

Termasuk faktor predisposisi.

Faktor Janin, Plasenta dan Selaput Ketuban

Faktor predisposisi malpresentasi dan malposisi janin

Faktor janin

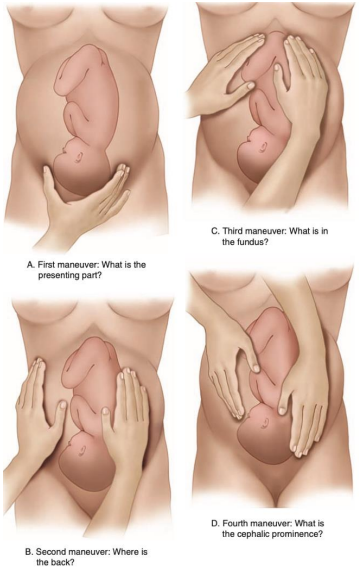
1. Janin besar
2. Presentasi bokong atau letak lintang
3. Rotasi internal abnormal: oksiput posterior atau gagal berotasi
4. Sikap janin: ekstensi menggantikan fleksi
5. Kehamilan multipel
6. Anomali janin: hidrosefalus, anensefalus
7. Polihidramnion: ruang gerak janin berlebih
8. Prematuritas

Plasenta dan selaput ketuban

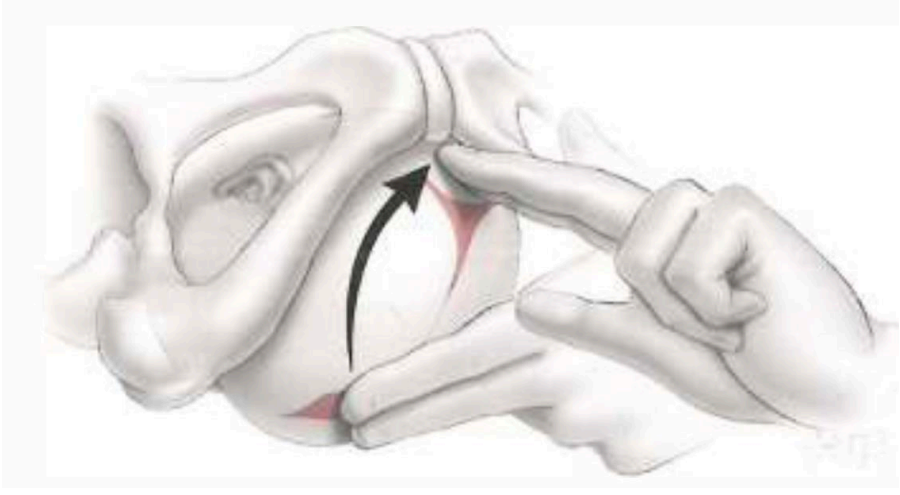
1. Plasenta previa
2. Implantasi plasenta di daerah kornu
3. Ketuban pecah sebelum persalinan

Diagnosis

Palpasi abdomen dan pemeriksaan dalam untuk menentukan letak, presentasi, dan posisi janin



Pemeriksaan Leopold I–IV



Pemeriksaan dalam (vaginal toucher)

Presentasi Janin dan Denominator

Bagian terendah janin dan titik acuan tulang untuk menentukan posisi

Jenis presentasi janin	Bagian tubuh yang berada di bawah	Denominator (titik acuan tulang)
Vertex / Belakang kepala	Puncak kepala (fleksi sempurna)	Occiput (tulang belakang kepala)
Breech / Sungsang	Bokong atau kaki janin	Sacrum (tulang kelangkang janin)
Face / Muka	Wajah janin (ekstensi penuh)	Mentum (dagu janin)
Brow / Dahi	Dahi janin (ekstensi sebagian)	Frontal bone / frontal eminence (tulang dahi)
Shoulder / Bahu (lintang)	Bahu janin	Acromion / scapula (tulang belikat / bahu)

Hubungan Fetopelvik Menurut Presentasi

Fetopelvic relationships according to fetal position

Presentation	Attitude	Presenting part	Denominator
Longitudinal lie (99,5%)			
Cephalic (96%–97%)	Flexion	Vertex (posterior part)	Occiput (O)
	Military	Vertex (median part)	Occiput (O)
	Partial extension	Brow	Forehead (frontum) (Fr)
	Complete extension	Face	Chin (mentum) (M)
Breech (3%–4%)			
Complete	Flexed hips and knees	Buttocks	Sacrum (S)
Frank	Flexed hips, extended knees	Buttocks	Sacrum (S)
Footling: single, double	Extended hips and knees	Feet	Sacrum (S)
Kneeling: single, double	Extended hips; flexed knees	Knees	Sacrum (S)
Transverse or oblique lie (0,5%)			
Shoulder	Variable	Shoulder, arm, trunk	Scapula (Sc)

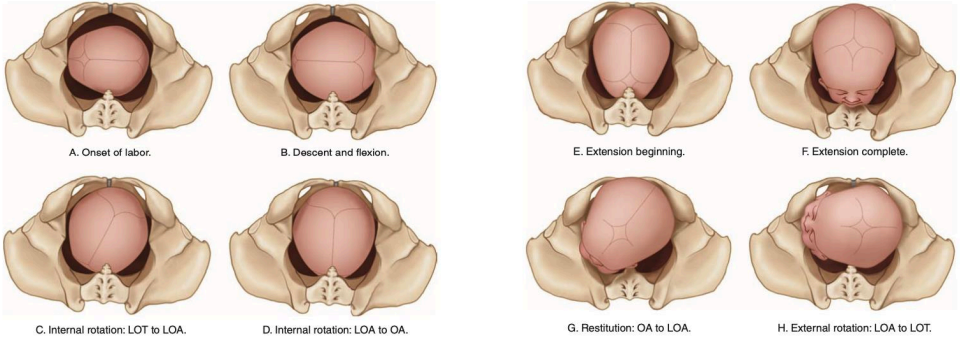
03

Mekanisme Persalinan per Presentasi Kepala

Belakang kepala · Puncak kepala · Dahi · Muka

Presentasi Belakang Kepala

Vertex / occiput presentation — mekanisme persalinan normal



SIKAP

Fleksi maksimal

PRESENTING PART

Vertex (bagian posterior)

DENOMINATOR

Oksiput (O)

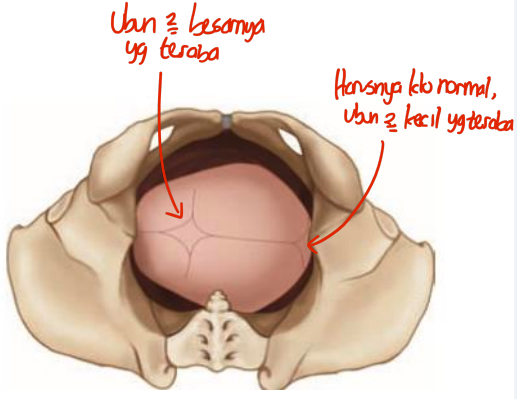
DIAMETER

Suboksipitobregmatika 9,5 cm

Presentasi Puncak Kepala

Sinciput presentation — military attitude





SIKAP

Fleksi parsial (military)

PRESENTING PART

Vertex bagian tengah / fontanel anterior

DENOMINATOR

Oksiput (O)

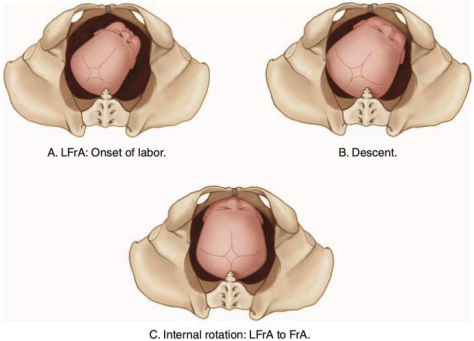
DIAMETER

Oksipitofrontal 11 cm

Presentasi Dahi

Brow presentation





SIKAP

Ekstensi parsial

PRESENTING PART

Dahi (brow)

DENOMINATOR

Frontum (Fr)

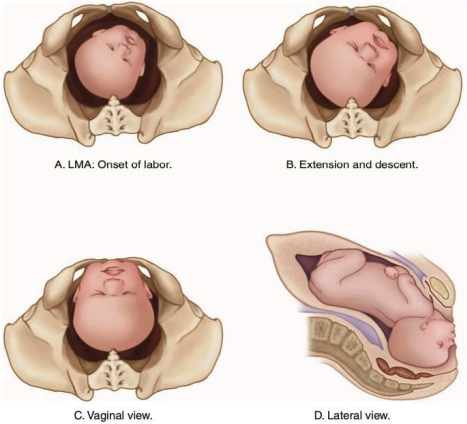
DIAMETER

Verticomental
13,5 cm

Presentasi Muka

Face presentation





C and D. Internal rotation: LMA to MA.

SIKAP

Ekstensi maksimal

PRESENTING PART

Muka

DENOMINATOR

Mentum (M)

DIAMETER

Submentobregmatika 9,5 cm

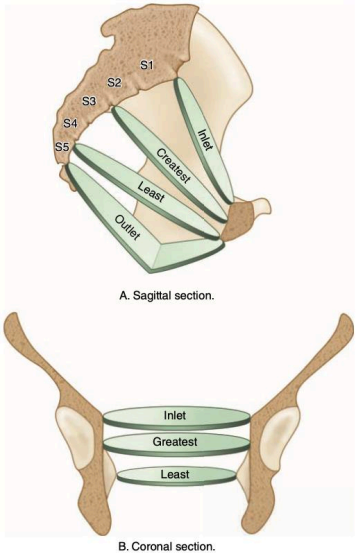
04

Passage, Passenger & CPD

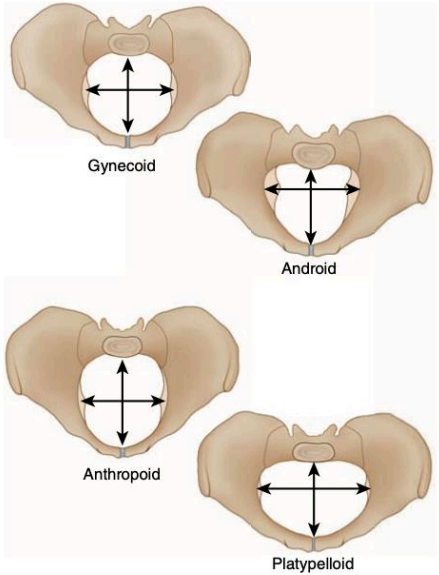
Jalan lahir · Bidang panggul · Kepala janin · CPD dan failure to progress

The Passage — Jalan Lahir

Bidang panggul dan tipe panggul

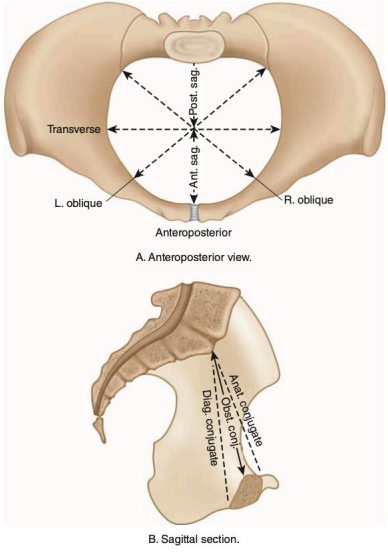


Bidang-bidang panggul (potongan sagital & koronal)

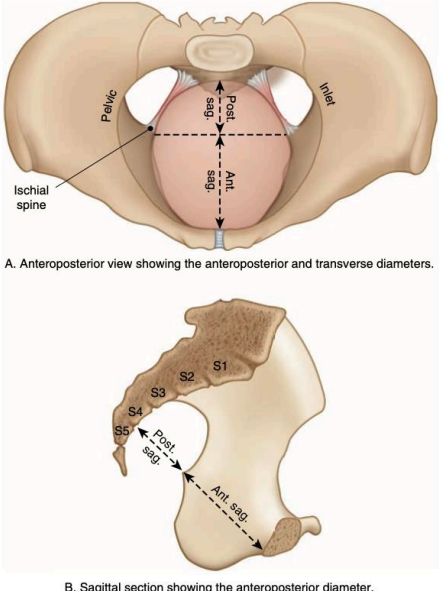


Tipe panggul: ginekoid, android, antropoid, platipeloid

Bidang Panggul: Inlet, Cavity, Outlet

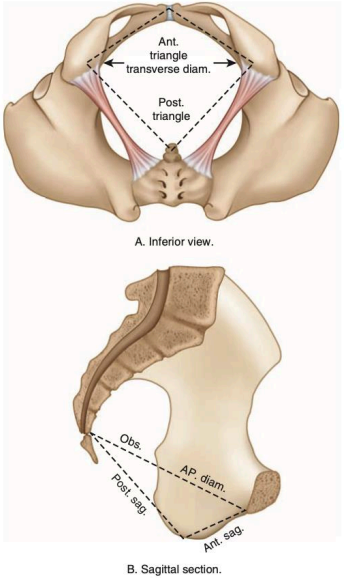


Pintu atas panggul (Inlet)



Bidang tengah panggul (Cavity)

Paling luas

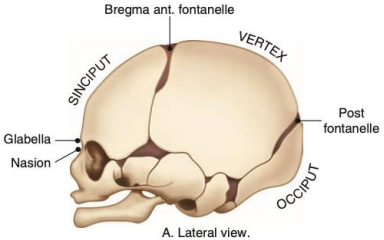


Pintu bawah panggul (Outlet)

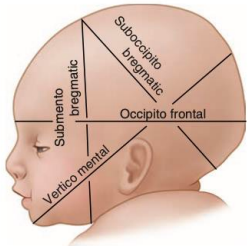
yg Sempit

The Passenger — Kepala Janin

Landmark tengkorak dan diameter anteroposterior kepala janin



A. Lateral view.



B. Anteroposterior diameters.

Diameter kepala janin

9,5 cm	**Suboksipitobregmatika** presentasi belakang kepala
11 cm	**Oksipitofrontal** presentasi puncak kepala
13,5 cm	**Verticomental** presentasi dahi
9,5 cm	**Submentobregmatika** presentasi muka

CPD dan “Failure to Progress”

Cephalopelvic disproportion dan keterbatasan istilah diagnostik

1 Asal istilah CPD

Sebelum abad ke-20, CPD menggambarkan obstruksi akibat ketidaksesuaian ukuran kepala janin dan panggul ibu.

2 Keterbatasan diagnosis

Sebagian perempuan yang menjalani sesar karena CPD kemudian dapat melahirkan bayi lebih besar secara vaginal pada kehamilan berikutnya.

3 Disproporsi absolut kini jarang

Banyak kasus berkaitan dengan malposisi kepala (asinklitismus) atau kontraksi uterus yang tidak efektif.

4 “Failure to progress”

Menggambarkan tidak adanya kemajuan dilatasi serviks atau penurunan janin, pada persalinan spontan maupun dengan stimulasi.

Kedua istilah tidak menjelaskan penyebab persalinan terhambat secara spesifik.